

GYNÉCOLOGIE

Dr.KHERBA_N

GYNÉCOLOGIE

Aménorrhée

Bartholinite

B_HCG

Bouffée de chaleur

Candidose vaginale

Contraception

Crevasses du mamelon

Début de grossesse

Diabète et grossesse

Dysménorrhée

Éclampsie

Endométriose

Engorgement mammaire

Exagération des signes sympathiques

Grossesse extra utérine

Hémorragie de la délivrance

Herpès génital

HTA gravidique

Infections et grossesse

Infections génitales

Menace d'accouchement prématuré

Menace d'avortement

Mentée laiteuse

Plaie de la césarienne infectée

Prééclampsie

Rupture prématurée des membranes

Sevrage de l'allaitement

Suite de couche

Syndrome des ovaires polykystiques SOPK

Aménorrhée secondaire

● Clinique:

■ Aménorrhée secondaire: absence des règles:

>3mois: si le cycle est régulier

>6mois: si le cycle est irrégulier

■ Test de grossesse: si c'est (-)

=> Progestérone: Duphaston du J16_J26

1cp 2/j pdt 10j si c'est >3mois

Ou Duphaston 2cp (même prise) 1/j pdt 10j

Saignement 2_7j après

■ Si les règles apparaissent: un traitement cyclique

J1: c'est le 1er jours des règles

Ensuite Duphaston de J16_J26 à chaque cycle

>1mois: 1cp/j pdt 10j à partir de J16

- +/- Échographie: pour éliminer une GEU

- Bilan: B_HCG

- 2 causes:

- Organique: Kystes ovariens

=> Duphaston 3mois puis contrôle

- Hormonale:

- Bilan :

- B_HCG

- TSH/T4

- Anti TPO

- FSH/LH

- Prolactinémie: si ↗

- Carbanex 1cp/sem pdt 1mois

Bartholinite

● Clinique :

Inflammation des glandes de Bartholin qui se situe derrière les lèvres du vagin et qui entraîne de fortes douleurs et un gonflement à l'entrée du vagin.

✓ Traitement :

1 Augmentin St 1st 3/j pdt 8j

2 Flagyl cp 1cp 2/j pdt 8j

3 Paracétamol cp 1cp 3/j

4 Saforelle sol 1app 2/j pdt 15j

Ou Bain de siège au KMnO_4

■ Si : récurrence => chirurgie

→ Avis gynécologie

B_HCG

- B_HCG à 1500UI/l + double chaque 48h

☐ → une grossesse normale et évolutive

- B_HCG > 1500UI/l avec une vacuité utérine à l'échographie endovaginale

☐ → GEU très probable

- Utérus vide à l'échographie
- Le sac gestationnel est visible à l'échographie:

▲ Endovaginale si BHCG >1500

▲ Sus pubienne si BHCG >2500

- BHCG <1000: Abstention thérapeutique avec surveillance échographie + BHCG chaque 2j (peut être il y aura une régression spontanée si non une complication qui nécessite une intervention chirurgicale)

■ Si le taux augmente très rapidement ($\times 3$ ou $\times 4$)

→ probablement une grossesse
gémellaire/grossesse molaire

Bouffée de chaleur chez la femme ménopausée

Clinique :

Sudations nocturnes dues à l'instabilité vasomotrice, débutent habituellement avant que les menstruations ne cessent.

Traitement :

1 Abufene cp 400mg 1cp 2/j pdt 10j

2 Doliprane cp 1g 1cp 3/j 2bte

Ou

- Manhaē menopause 1cp/j pdt 4mois pdt repas
- Juvamine menopause 1cp avant coucher pdt 1mois à renouveler si besoin
- Biomax menopause cp 500mg 1cp/j
- Gynofene 1_2cp/j pdt 10j renouvelables

→ Avis gynécologie si persistance des
symptômes

Candidose vaginale

Mycose vaginale

● Clinique :

Démangeaisons de la vulve et du vagin,
écoulements épais et blanchâtres

✓ Traitement :

- Toilettes avec savon alcalin : Hydralin gyn, sécher
- Sous vêtements en coton

⊖ Ovules sont contre indiqués chez la femme vierge.

1 Gyno pevaryl LP ovule 1 ovule le soir en intravaginale

A renouveler au bout de 3j si persistance des symptômes

Ou Diflucan ovule gyn 150mg 1ovule/sem pdt 3sem

Ou Fluconazole cp 150mg 1cp/sem à renouveler après 1sem 3btes 3sem

Ou Tergynan cp

2 Pevaryl lait si prurit 1app 2/j sur peau sèche et propre pdt 21j

3 Dermofix/Ketoderm pmd 1app 2/j le soir

4 Toilette avec l'eau Bicarbonatée

5 Hydralin gyn/Dermobacter/Saforelle gel intime 1app/j

■ Si récurrence >4 fois par ans=> prélèvement vaginal pour examen mycologique.

■ Traitement de partenaire : Pevaryl lait 1app/j pdt 1sem

■ Chez une fille vierge : non mariée

[1] Fluconazole gel 150mg 1gel/sem pdt 3sem

[2] Dermofix/Stopmycose/Econazole pmd 1app
2/j

[3] Rosagyn/Saforelle sol 1 toilette/j

■ Allaitement et grossesse

[1] Gynodermofix 300mg / Ecovar / Mycoten
500mg ovule

[2] Mycoten crème

Contraception

● La première fois : le 1^{er} jours des règles, lorsque la patiente n'était pas sous OP, plus tard le 5^{ème} jours

- Schéma de 21j : pilules combinées :

- 1cp/j pdt 21j

- Arrêt de 7j (règles)

- Puis reprise d'une nouvelle plaquette

→ Ex : Microgynon, Logynon, Mercilon, Méliane, Adépal

- Si oubli <12h : prendre le cp puis continuer la plaquette

- Si >12h : même + utiliser une méthode de contraception locale jusqu'à la fin de plaquette

- Schéma continu : progestatifs seules : 1cp/j sans pause, prise à une heure fixe

- ⇒ Allaitement

- Ex : Cerazette, Microval

- Pour changer la pilule faut demander un bilan

- Bilan avant et après 3mois :

- Glycémie à jeun

- Lipidique

- Prise de TA

Crevasses du mamelon

● Clinique :

- Fissure ou érosion, douleur unilatérale.
- Continuer l'allaitement.

✓ Traitement :

- Séchage et nettoyer du mamelon avant et après chaque tété
- Changer la position de l'allaitement
- Compresse imbibée de lait maternel
- Porter des soutiens de gorge d'allaitement
- Ne pas arrêter l'allaitement, espacer de l'app
1h

- Mamlocare pmd
- Mamocalm crème
- Pitchoune mercurochrome crème
- Mustella anticrevasses
- Uriage bariderme cica
- Lanoline
- Mebo pmd
- Sito heal
- Miel naturel
- Huile d'olive

Début de grossesse

- Zanitra cp 5mg 1cp 1_2/j

3 mois avant et au début de grossesse

- Genesia cp 1bte

- Solyne grss cp 1cp/j

- Nosiflux 1cp/j si nausées/vomissements

- TA

- Bilan : 

- Dépistage de diabète gestationnel le 7^{ème} mois de grossesse

- Gly à jeûne

- FNS

- TP/TCK

- Rénal/Hépatique

- TSH

- Vit D

■ Sérologie :

■ Toxo

■ Rubéole

■ HBS

■ HVC

■ HIV

■ BW (Syphilis)

■ Chimie des urines

■ Échographie de 6SA

Diabète et grossesse

● Clinique :

- Diabète pré gestationnel : Gly à jeûne $>1,26\text{g/l}$
 7mmol/l à 2 reprises

Ou $>2\text{g/l}$ 11.1mmol/l à n'importe quel moment de la journée

- Diabète gestationnel : intolérance au glucose de sévérité variable

- Dépistage entre 24_28SA par HGPO avec 75g du glucose

- CI de la grossesse chez la diabétique :

Absolue :

- Rétinopathies évolutives

- Néphropathie diabétique avec IR

- Lésions cardiaques

Temporaire :

- Mauvais équilibre glycémique

- Surveillance de glycémie pdt la grossesse :
- But gly à jeûne : 0.6_0.95g/l
- Postprandial 2h : 1.20g/l
- Pas d'antidiabétiques oraux
- RHD
- Insulinothérapie si échec des RHD

- Surveillance :
- PA
- Poids
- Urée/Créat
- Protéinurie
- FO si rétinopathie
- BU

- Autosurveillance par glycémie capillaire 6×/j
- Consultation/15j

- Surveillance obstétrique : Echographie + ERCF
- Rechercher les complications du fœtus :
macrosomie, hydramnios, cardiomyopathies
hypertrophiques, malformations..

- Pas de CI au CTC mais sous surveillance de
glycémie (pour accélérer la maturation
pulmonaire)

Dysménorrhée

● Clinique :

Douleurs survenant au moment des règles.

■ En urgence :

- Spasfon 1amp ou 1amp Voltarene 75mg en IM
- Si Vomissements 1amp Primperan

✓ Traitement de sortie :

1 Xydol gyn cp 100/400mg 1cp 2/j pdt 5j

Ou Antalfen gyn cp 100mg 1cp/6h

Ou Clofenal suppo 100mg

2 Spasfon cp 80mg 2cp 3/j

3 Proton gel 20mg 1cp le matin à jeûne

Éclampsie

● Clinique:

Crises convulsives à répétition suivies d'un état comateux, aux derniers mois de grossesse, à partir de 20SA

■ Prééclampsie sévère:

- Céphalées
- Troubles oculaires
- Troubles digestifs
- HELLP syndrome

✓ Traitement:

- Valium + O2 thérapie au masque: 250mg en IVL
- Sulfate de Mg 4g en IVL puis 1_2g/h
- AntiHTA: Loxen 2amp et demi dans 250cc de SG ou SE

- Crise d'éclampsie:
- Valium 10Ui en IV
- Sulfate de Mg

Endométriose

● Clinique :

- Patient consulte pour : infertilité, douleur ou troubles de cycles
- Douleur pelvienne chronique, irrégularité menstruelle, dysménorrhée, dyspareunies, diarrhée, dysurie, pollakurie, hématurie, asymptomatique..
- Examen : masse annexielle, nodules au niveau du col et vagin, rétroversion utérine fixée, mobilisation utérine douloureuse..
- Échographie abdominale et vaginale
- Coelioscopie
- Marqueurs tumoraux : Ca125 Ca19

✓ CAT :

1 Traitement symptomatique : Douleur

Endométriose minime à manifestations uniquement menstruelles=> AINS : efficace sur les dysménorrhées et l'inflammation

2 Progestatifs à dose antigonadotrope :

2_6mois=> atrophie glandulaire

- Progestatifs antiœstrogénique et antigonadotrope
- Pilules œstroprogestatifs
- Agonistes LHRH

3 Chirurgie

Engorgement mammaire

- Paracétamol
 - Hydratation/Repos
 - Faire extraire le max du lait avec tire lait
 - Allaiter le bébé chaque 2_3h
 - Compresses chaudes avant le tété puis froides après pdt 10_15min, avec un massage
 - Si fièvre, rougeur ou douleur localisée
- début de mastite

Exagération des signes sympathiques

● Clinique:

Céphalées, nausées/vomissements

- Prise de TA

- ECG

- Bilan: 

- FNS

- TSH: Hyperthyroïdie

- Glycémie à jeun

- Urée/Créat

- TGO/TGP

- Ionogramme: hypoNa ou K

- Si bilan perturbé: Hospitalisation
- Réhydratation et correction des troubles ioniques
- Primperan 1amp dans une perfusion
- Mopral 40mg/j

✓ Traitement de sortie: symptomatique

- Cariban cp 10mg

Ou Vogalene suppo 5j

Grossesse extra utérine GEU

● Clinique :

■ Triade fonctionnelle :

Douleur + Métrorragies + Syncope

■ Douleur : unilatérale type de pesanteur pelvienne ou paroxystique type colique

■ Métrorragie : brun sépia, mare de café peu abondante et récidivante

HypoTA, hyperthermie, signes sympathiques de grossesse..

■ Au spéculum : col violacé

■ TV : Utérus ramolli, volume inférieure à l'âge gestationnel

⇒ Femme en âge de procréer avec douleur pelvienne et saignement noirâtre

- Dosage de β -HCG : des taux de 10 à plus de 100.000UI/L

- Échographie pelvienne : Confirme le diagnostic

-  Traitement :

- Supprimer la GEU et sauvegarder la vie maternelle

- Traitement médical : Méthotrexate

- Indications :

- GEU pauci symptomatique ou peu évolutive sans activité cardiaque avec β -HCG <10000ui/l

- GEU sur trompe unique ou interstielle

- Score de Fernandez <13

- Chirurgie : GEU rompue ou compliquée

2-Méthodes et Indications :

2-1 Expectative :

- Si patiente asymptomatique avec taux de β hCG décroissant.

Score de FERNANDEZ

	1	2	3
Douleur	-	Provoquée	spontanée
Aménorrhée	> 07 sem	<= 07 sem	<= 06 sem
HCG	<=1000UI/ml	<=5000 UI/ml	>5000 UI/ml
Progestérone	<=05mg/ml	<= 10mg/ml	>10 mg/ml
Hematosalpinx	<= 01cm	<= 03cm	>03cm
Hémopéritoine	<=10ml	<=100ml	>100ml

Score < 11 : Abstention ;

Score 11 – 13 : Traitement médical ;

Score >13 : Traitement chirurgicale

Hémorragie de délivrance

● Clinique : Etat de choc

■ Utérus : mal involué, mou dépasse l'ombilic

■ Échographie pelvienne

■ Bilan : 

■ FNS

■ TP

■ TCK

■ Fibrinogène

■ DDIMÈRES

■ PDF

✓ CAT :

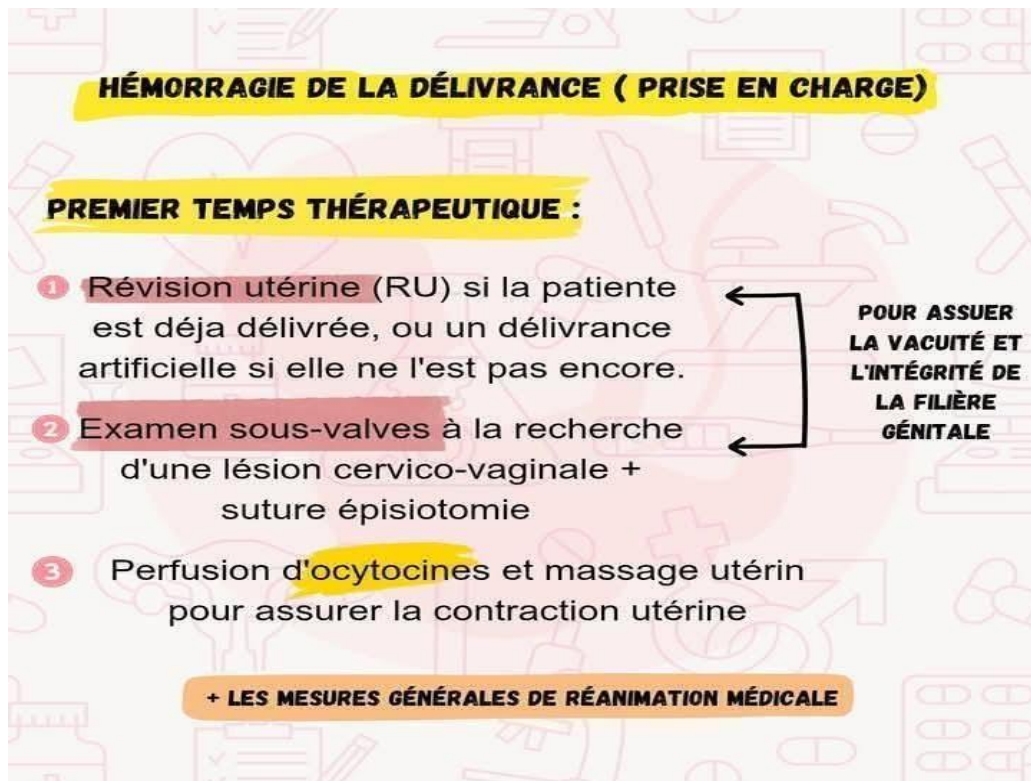
- Réanimation :
- O2 thérapie/2VVP
- Sondage vésicale
- Bilan d'urgence
- Commande du sang
- Remplissage par les macromolécules en attendant la transfusion sanguine
- Monitoring cardio tensionnel

■ Placenta non extériorisé=> Délivrance artificielle++

Révision utérine

- Placenta extériorisé=> Révision utérine+++
- Ocytocine + ATB
- Massage utérin
- Ocytocine 5_10ui en IM ou IVL renouvelable max 40ui

- Si échec : Perfusion de prostaglandines
- Si échec : Tamponnement
- Si échec : Embolisation
- Si échec : Chirurgie



Herpès génital

● Clinique :

Des vésicules sur le pénis, scrotum, lèvres, vagin, cuisse super, fesses et anus.

✓ Traitement :

Zovirax cp 200mg 1cp 5/j pdt 7_10j

Ou Zovirax pmd 1app 5/j

Ou Clovir cp 200mg 1cp 5/j

Ou Aciclovir pmd 2app/j

+ Hexomedine sol 1app 3/j



HTA gravidique

● Clinique :

- Grossesse de 20SA
- Signes fonctionnels : Acouphènes, phosphènes, barre épigastrique
- Œdème avec prise du poids
- Troubles de conscience
- PA : 14/9
- Repos puis faire une prise de TA
- Bilan : 
- FNS
- TP
- Urée/Créat
- Uricémie
- Protides totaux

- Albuminémie
- Fibrinurie
- Hépatique
- Ionogramme
- Diurèse ↘ et Protéinurie des 24h

- Surveillance fœtale :
- Mouvements actifs fœtaux
- Rythme cardiaque fœtal
- Echodoppler

✓ CAT :

- Si patient stable : traitement antiHTA

Loxen, Trandate, Aldomet

- Surveillance : dinamap, poids, diurèse, bilan biologique, Protéinurie, ERCF, Echodoppler

- Si patient instable ou anomalie du RCF :
 - ⇒ Seul traitement Extraction fœtale
- O2 thérapie + Mg
- Loxen 1cc dilué dans 3cc de SSI/SG5% + CU

■ Si amélioration => Bilan HTA + Profil de TA

Protéinuries des 24h

→ Orientation gynécologie

Infections et grossesse

● Listériose :

- Ingestion des aliments mal crus mal cuits (viandes..) lait et fromage non pasteurisés
- Toute fièvre chez une femme enceinte est une listériose jusqu'à preuve du contraire
- Syndrome pseudo grippal, fièvre, frissons, asthénie, myalgies, céphalées, troubles digestifs
- Hémoculture : Isolement de germe

✓ Traitement :

Amoxicilline 3_6g/j per os pdt 2j

Si >34SA : Déclenchement de l'accouchement

● Gonococcie : IST

- Ophtalmie purulente de nouveau né donc instillation systématique obligatoire de nitrate d'argent ou un collyre ATB

● E_Choli :

- Risque néonatal : septicémie, méningite
- Dépistage : BU
- Pyélonéphrite : contractions utérines fréquentes
- Risque de MAP, chorioamniotite, prématurité
- ECBU : > 105 éléments/ml
- Si gravité : Echographie rénale et obstétrique
- ERCF

✓ CAT : Hospitalisation

- ATB : 15_21j
- Si gravité : Aminosides

- PEC de MAP : Tocolyse + CTC
- Contrôle régulier de ECBU jusqu'à l'accouchement

● Rubéole :

- Fièvre, myalgies, arthralgies, éruptions cutanées (visage puis tronc et membres supérieurs sous forme de taches rouges macules), ADP..

- Si 1^{er} trimestre => rubéole congénitale

Après 18SA risque quasi nul

- Sérologie rubéole est obligatoire au début de grossesse
- Si contage : inj des gammaglobulines

● Hépatite B

- Ictère, vomissements, prurit

↗ Transaminases

- Transmission lors de l'accouchement ou à l'allaitement
- Risques : pas les malformations mais : la prématurité et mort in utéro
- Hépatite C même risque que Hépatite B

● Toxoplasmose :

- Fébricule, syndrome grippal, syndrome mononucléosique, ADP
- ⇒ Toxoplasmose congénitale surtout 10_24SA

- Dépistage : Dosage des IgM et IgG
- IgG (+) IgM (-) : femme immunisée sans risque
- IgG (+) IgM (+) : Infection en cours

Recherche une infection foétale=>

Amniocentèse et des malformations par échographie

- IgG (-) IgM(+) : Infection récente

Refaire la Sérologie après 15j

- IgG (-) IgM(-) : femme non immunisée

Prévention + Sérologie chaque mois

✓ CAT :

- Femme enceinte (+) : pas de traitement
- Femmes enceinte (-) : RHD + Sérologie mensuelle
- Laver bien les mains
- Viandes très bien cuits
- Éviter les chats et animaux domestiques
- Si séroconversion : Spiromycine ou Rovamycine par cures de 10j par mois jusqu'à l'accouchement
- Si diagnostic périnatal (+) :
Association en cures de 4sem de Macrolide (Pyrimethamine) + Sulfadiazine en alternance avec Rovamycine pdt 2sem

Infections génitales

● Clinique :

- Symptômes d'une infection basse :

Leucorrhées, dyspareunies, prurit ..

- Symptômes d'une infection haute :

Leucorrhées, fièvre, douleur pelvienne..

- Bilan : si suspicion d'infection haute

- FNS/CRP

● Leucorrhées blanchâtres : mycose à Candida Albicans

[1] Fluconazole gel 150mg 1gel/j à renouveler après 2 semaine

[2] Polygynax ovule 1_2ovules/j pdt 10j

Ou cp 150mg 1/j

[3] Saforelle/Dermobacter

● Leucorrhées verdâtres : Trichomonas Vaginalis

1 Tergynan ovule 2ovules/j pdt 10j

2 Flagyl cp 500mg 4cp per os en 1 seule prise
Ou 500mg 1cp 2/j pdt 7j (Enfant: 250mg selon poids)

Ou Secnidazole sachet 2g en prise unique

3 Savon de Marseille Ou Lactacyd lotion

● Leucorrhées jaunâtres : Gonocoque

1 Vibramycine cp 100mg 1cp/j à renouveler après 2sem si l'infection est importante

Ou Extencilline inj 1inj/j pdt 4j

Ou Ceftriaxone IM

2 Oroken cp 2cp en prise unique

● Leucorrhées transparentes :

Rovamycine cp 3M 1cp 2/j pdt 10j

● Infection haute :

- 1 Ceftriaxone cp 1g 1cp/j
- 2 +/- Doxycycline cp 100mg 2/j
- 3 Flagyl cp 500mg 2/j pdt 10j

■ Femme enceinte :

- 1 Polygynax ovule 1ov/j le soir
Ou Gynodermoderfix ovl 300mg 1ovl/sem
- 2 Ketoskin pmd/Dermofix
- 3 Mylagyn sol/Saforelle

■ Femme non mariée :

- 1 Fluconazole cp 150mg en une seule prise
- 2 Augmentin
- 3 Dakin sol

- Ménopause : pas d'infection à candida albicans (Ph alcalin)
- Prurit à cause de la sécheresse vaginale
- Acide hyaluronique ovule :
Cicatrine/Gyntima/Hyalgyn ovule pdt 10 j
Ou Ovestin ovl pdt 10j chaque mois

 Hospitalisation si :

- Suspicion d'abcès ou pelvipéritonite
- Signes génériques marqués
- Grossesse...

Menace d'accouchement prématuré

MAP

● Clinique :

- Contractions utérines douloureuses régulières, rapprochées
- Modification cervicale de TV : col effacé, perméable..
- Poche des eaux bombante ou rompue
- FDR :
- ATCD d'accouchement prématuré
- Grossesse multiple
- Métrorragies de T1 ou T2
- Utérus mal formé
- Poids maternel < 45kg, âgé <18 ou >35ans
- Travail pénible ou long trajet
- Grossesses rapprochées

■ Bilan : 

■ FNS

■ CRP

■ ECBU

✓ CAT :

■ Repos

■ Hospitalisation si modéré ou sévère

■ Traitement étiologique : Rechercher une infection..

■ Bilan pré thérapeutique et recherche une CI à la Tocolyse : Chorioamniotite, souffrance foetale, Métrorragie importante

1 Tocolyse pdt 48h :

■ Inhibiteur calcique per os : Adalate en 1^{ère} intention

■ Antagoniste d'ocytocine : Tractocile en 2^{ème} intention

2 CTC : entre 24_34SA=> maturation pulmonaire

Bethamethasone 12mg 1inj en IM

A renouveler 24h après

3 Sulfate de Mg : avant 32SA si Accouchement imminent spontané ou programmé

Dose de charge 4g puis 1g jusqu'à l'accouchement

■ Progestérone (Utrogestan) avant 32SA en 2^{ème} intention

■ Cerclage prophylactique si béance cervico isthmique

- L'évaluation du degré de gravité de la MAP fait appel à différents scores ;
- le plus utilisé est celui de **BAUMGARTEN**:

--- <3 MAP légère

--- entre 3 et 6 MAP modérée

--- >6 MAP sévère)

	0	1	2	3	4
Contractions utérines	0	Irrégulières	Régulières		
Membranes	Intactes		Rupture haute		Rupture basse
Métrorragies	0	Métrorragies peu importantes	Hémorragies		
Dilatation du col	0	1cm	2cm	3cm	4cm ou +

Menace d'avortement

● Clinique :

- Métrorragies + Douleur pelvienne
- Douleur intermittente type contractions utérines
- Métrorragie : importante avec des caillots, Ecoulement de liquide amniotique
- Examen :
 - Origine de saignement endoutérin
 - Utérus mou et ↗ ou ↘ de volume par rapport à l'âge gestationnel
 - Sensibilité utérine
 - Col fermé parfois dilaté
- Échographie

✓ CAT :

- Repos
- Ac folique
- Spasfon pour la douleur

Mentée laiteuse (favoriser↗)

- Boire beaucoup +++ et bien manger
- Vérifier la position de l'allaitement

✓ Jusqu'à ce que l'allaitement soit bien rétablie :

- Phylait gel 1gel 3/j matin midi et soir
- Myralait cp 1cp 3/j
- Lactomax 1cap/j
- Stimulait
- Theralact
- Vitonic
- Si non : médicament
- Sulpiride 100_150mg/j répartie en 3prises pdt 15j

⚠ Attention : il passe dans le lait..

Ou Domperidone 10mg 3/j

■ Tisanes :

حلبة

زريعة البسباس

حبة الحلاوة

Plaie de césarienne infectée

Infection d'épisiotomie

☒ CAT :

- Hospitalisation
 - ECB + AntibioGramme du pus
 - FNS/CRP
 - ATB en IV : Claforan 1g 3/j
+ Flagyl 400mg 2/j
 - Soins 2/j

 - Surveillance clinique/FNS/CRP
 - Échographie pour éliminer un abcès de la paroi qui nécessite un Drainage
- ☐ Avis gynécologie

Prééclampsie

● Âge gestationnel : à partir de 20SA

■ Associée : TA $\uparrow$ + Protéinurie >3g/24h Ou

➤ A (++) CU

■ Œdème + HTA + Protéinurie +++

🔍 Rechercher :

■ OMI

■ OAP

■ $\uparrow$ Urée : 350Umol/l=> Début d'IR et une souffrance placentaire

■ Facteurs hépatiques

■ Thrombopénie 150.000

■ RCIU retard de croissance

✓ CAT : Prééclampsie sans crise (que les signes)

- O2 thérapie/VVP

- Surveillance des paramètres

- Perfusion de Mg 2cc diluées dans SG5%

- Si pas de signes neurologiques et TA pas très ↗ :

Aldomet per os : 1cp/8h

- Si échec 2cp/8h puis 2cp/6h

- Si non ajouter Nicardipine 1cp/12h

Ou Loxen 1cc dilué au SSI en IVD

- Si signes neuro :

- Mg 2amp diluées dans SG5%

- ATB

- Si crise => Valium

→ Avis gynécologie

- Si Douleur

épigastrique/dyspnée/crépitements/Oligo anurie

☞ Évacuation gynécologie

⊖ Complication :

- Hellp syndrome : diagnostic biologique

- Hémolyse

- ASAT/ALAT ↑

- Thrombopénie

- Bilan Complet : 

- FNS

- Glycémie

- Rénal

- Hépatique

- Hémolyse

- Protéines des 24h

- BU

Rupture prématurée des membranes RPM

- Âge gestationnel
- Aspect de liquide
- FC de fœtus
- FNS/CRP/48h

- Si: apyrétique, liquide clair, ERCF normal

☞ Orientation Eph

- Si: fébrile, liquide verdâtre, ERCCG pathologique

☞ Evacuation

🏠 Hospitalisation:

- Repos stricte
- Courbe de température rectale

- Surveillance fœtale par ERCF (tachycardie fœtale).

- Echographie AP

- Amoxicilline 1g 2/j

- <34SA=>Tocolyse + Dexa pour la maturation pulmonaire

- >34SA=> attendre le travail si non déclenchement (synto)

>12h:

- Malade proche de 9mois, malade >2 doigts, liquide clair: CRP si => risque d'infection fœtale

 Déclenchement: Sapsfon 2amp dans SSI9%

- Liquide verdâtre, toujours 1 doigt:

 Césarienne

- Grossesse 27_32SA: liquide clair, 1_2D

☞ CTC: Dexaméthasone + ATB

- Surveillance CRP

- Échographie rapprochées

- Éviter un grand prématuré (au moins 32SA)

- Si malade s'ouvre, liquide teinté, CRP↑:

Continue l'accouchement

Sevrage de l'allaitement

⊖ Doit être progressif

✓ Dostinex cp 0.5mg 1/2cp 2/j pdt 2j

▪ Inhibition de la lactation (24h après l'accouchement) : 2cp en une seule prise

▪ Suppression de la lactation déjà établie :

1/2 cp 2/j

▪ Hyperprolactinémie : 1cp/sem pdt 4sem

Ou

✓ Parlodel cp 2.5mg

1/2cp le 1^{er} j

1/2cp 2/j le 2^{ème} j

1cp/j pdt 13j

Ou

✓ Cabernex 1cp le 1^{er} jour puis 1cp le 2^{ème} j

Puis 1cp/sem

Suite de couche

- 1 Cefacet cp 1g 1cp 3/j pdt 10j
- 2 Cerazette cp 75mg 1cp/j à partir de 21^{ème} j du pp pdt 3mois
- 3 Tardyferon 1cp/j Ou Fumafer 2cp/j
- 4 Lovenox 0.4 inj 1inj/j en Sc à heure fixe
- 5 Saforelle sol 1app 3/j

Syndrome des ovaires polykystiques SOPK

● Clinique :

- Affection hormonale courante chronique et incurable, qui touche les femmes en âge de procréer. Il commence habituellement pendant l'adolescence
 - Déséquilibres hormonaux, ↑ androgènes, kystes dans les ovaires
 - Règles irrégulières, avec un manque d'ovulation, peuvent rendre difficile la grossesse
 - Principales causes d'infertilité.
 - Diagnostic : Clinique/Biologique/Radiologique
-
- Bilan : 
 - FSH/LH
 - Prolactine
 - Testostérone

- Androstenidione
- 17_ohp
- DHEA_S
- Gly à jeûne
- HBA1C
- Insulinémie à jeûne
- Lipidique (CT, TG, HDL, LDL)
- TSH (hypothyroïdie)
- SHBG↘
- AMH
- 17 Hydroxyprogésterone (hyperplasie des surrénales)

- Échographie

✓ CAT :

- Régime alimentaire sans sucre
- Activité physique
- Traitement hormonal → Gynécologie
- Si Hirsutisme → Endocrinologie